UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Pneumologie
SUJET 2 : Imagerie d'embolie pulmonaire
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Kalfon Eva **Date de rédaction : 07/12/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 230 – Découverte d'une anomalie cardio-thoracique à l'imagerie médicale

Domaine de compétence n°1 : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Domaine de compétence n°2 : Urgence

Attendus d'apprentissage de la situation abordée

1- Intégrer l'anomalie d'imagerie au contexte clinique et paraclinique

2- Evaluer le degré d'urgence de la prise en charge - familles

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Items de connaissances abordés : Item 226 – Embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin : NON
- Brancard : NON
- Photos des examens paracliniques (résultats de l'ETT, scanner thoracique, troponine) *(à donner dès le début de la station)*

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne de garde aux urgences de Nice. Vous recevez M. Lamoisier, un patient de 54 ans aux antécédents d'HTA, de BPCO et fumant 1 paquet par jour depuis 20 ans.

Il se présente pour une douleur thoracique brutale étant arrivée il y a 2 heures alors qu'il regardait la télévision. Il vous dit être revenu d'un voyage en avion de 10 heures.

A l'examen clinique, il est dyspnéique, présente un mollet rouge, chaud et douloureux. L'auscultation pulmonaire retrouve un murmure vésiculaire bilatérale et symétrique sans bruit surajouté. L'auscultation cardiaque est normale.

Les constantes prises par l'infirmières sont les suivantes : Sat 89 %, PA 112/74 mmHg, FC 112 bpm, T 37.4°C, FR : 19 cycles/min

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Décrire l'imagerie et énoncer votre hypothèse diagnostique principale en justifiant votre hypothèse
2. Enoncer la prise en charge précoce de ce patient (traitement et lieu d'hospitalisation) – *énoncer à voix haute chaque étape de votre réflexion*

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Dit qu'il s'agit d'un scanner **thoracique + injecté**	
Dit qu'il s'agit d'une coupe axiale	
Dit qu'il s'agit d'une fenêtre médiastinale	
Identifie l'embolie pulmonaire	
Dit qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire bilatérale	
Dit qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire proximale	
Justifie l'EP par au moins 3 éléments parmi les suivants : mollet rouge et douloureux, voyage en avion de 10 heures, douleur thoracique brutale, désaturation, imagerie compatible avec l'hypothèse	
Tache 2	
Calcule le sPESI à 3	
Dit qu'il s'agit d'une EP à risque intermédiaire – élevé	
Dit qu'il faut hospitaliser le patient en USI (unité de soins intensifs)	
Dit qu'il faut anticoaguler le patient (HBPM ou HNF)	
Dit qu'il faut l'anticoaguler de manière **curative**	
Prescrit de l'oxygénothérapie	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	1 à 5

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Dit qu'il s'agit d'un scanner **thoracique**	4
Dit qu'il s'agit d'une coupe axiale	4
Dit qu'il s'agit d'une fenêtre médiastinale	3
Identifie l'embolie pulmonaire	5
Dit qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire bilatérale	4
Justifie l'EP par au moins 2 éléments parmi les suivants : mollet rouge et douloureux, voyage en avion de 4 heures, douleur thoracique brutale, désaturation, imagerie compatible avec l'hypothèse	4
Note l'absence de fibrose pulmonaire	2
Tache 2	
Calcule le sPESI à 3	3

Dit qu'il s'agit d'une EP à risque intermédiaire - élevé	4
Dit qu'il faut hospitaliser le patient en USI (unité de soins intensifs)	4
Dit qu'il faut anticoaguler le patient (HBPM ou HNF)	4
Dit qu'il faut l'anticoaguler de manière **curative**	3
Evoque le relais par AVK ou AOD à 48-72 heures après amélioration clinique	2
Prescrit de l'oxygénothérapie	3
	/50
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	1 à 5
Note totale	**/60**